

Dermatitis Atópica

1. Introducción y relevancia clínica

La **dermatitis atópica (DA)** es una **enfermedad inflamatoria crónica y recidivante de la piel**, caracterizada por **prurito intenso, piel seca (xerosis) y lesiones eccematosas típicas** según la edad.

Es la **enfermedad cutánea inflamatoria más frecuente en la infancia**, afectando hasta un **20% de los niños** y un **2–5% de los adultos** en Chile.

Su relevancia radica en:

- Alta **prevalencia pediátrica y comorbilidad alérgica** (asma, rinitis, alergias alimentarias).
 - **Impacto en calidad de vida**, sueño y salud mental.
 - Asociación con **infecciones cutáneas recurrentes** por *Staphylococcus aureus*.
 - Frecuente pregunta en **EUNACOM**, especialmente en diagnóstico clínico, manejo básico y educación del paciente.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La dermatitis atópica resulta de la **interacción entre factores genéticos, inmunológicos y ambientales** que alteran la **barrera cutánea** y la **respuesta inmune**.

2.1. Alteración de la barrera cutánea

- Defecto en la **filagrina**, proteína estructural del estrato córneo → pérdida transepidérmica de agua → **xerosis** y aumento de permeabilidad a irritantes y alérgenos.
- Aumento del pH cutáneo → alteración del microbioma → colonización por *S. aureus*.

2.2. Respuesta inmune anómala

- Predomina una respuesta **Th2** (IL-4, IL-5, IL-13), que favorece producción de **IgE** y eosinofilia.

- En fases crónicas, se agrega componente **Th1** con engrosamiento e inflamación persistente.

2.3. Factores ambientales y predisponentes

- Antecedentes personales o familiares de atopia.
 - Climas fríos o secos, detergentes, estrés, alimentos, ropa de lana.
 - Alteraciones del sueño, ansiedad o depresión.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones cardinales

- **Prurito intenso** (signo más característico).
- **Xerosis cutánea generalizada.**
- **Lesiones eccematosas** que varían según la edad y la cronicidad.
- Curso **crónico-recidivante**, con exacerbaciones.

3.2. Lesiones típicas según edad

Etapa	Localización típica	Tipo de lesión	Características
Lactante (2 meses–2 años)	Mejillas, cuero cabelludo, tronco, superficies extensoras	Vesículas, pápulas, exudado	Respeto zona del pañal
Niñez (2–12 años)	Pliegues antecubitales y poplíteos, cuello, muñecas	Pápulas y placas liquenificadas, costras por rascado	Prurito crónico

Adulto/adolescente	Pliegues, cara, párpados, cuello, manos	Lesiones secas, eccematosas, liquenificadas	Frecuente en manos y párpados
---------------------------	---	---	-------------------------------

3.3. Hallazgos asociados

- **Dermografismo blanco.**
- **Pliegues infraorbitarios de Dennie-Morgan.**
- **Piel seca, rugosa (“piel de lija”).**
- **Signo de Hertoghe:** pérdida de cola de cejas.
- **Infecciones secundarias:** impétigo, eczema herpético.

3.4. Diagnóstico diferencial

Patología	Características distintivas
Psoriasis	Placas bien delimitadas, escamas plateadas, sin prurito intenso
Dermatitis seborreica	Escamas amarillentas en áreas seborreicas (cejas, pliegues nasogenianos)
Escabiosis	Prurito nocturno, surcos acarinos, contagio familiar
Contact dermatitis	Relación clara con exposición a irritante o alérgeno
Inmunodeficiencias (pediátricas)	Infecciones graves recurrentes, falla del crecimiento

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

La DA es **clínica**, no existen pruebas específicas.

El **criterio de Hanifin y Rajka** (modificado) es el más usado:

Criterios mayores (≥3 para diagnóstico)

1. Prurito intenso.
2. Morfología y distribución típica.
3. Curso crónico o recidivante.
4. Antecedentes personales o familiares de atopia.

Criterios menores

Xerosis, queratosis pilar, pliegues de Dennie-Morgan, dermatografismo blanco, elevación IgE, intolerancia a lana, inicio precoz, susceptibilidad a infecciones cutáneas, entre otros.

4.2. Exámenes complementarios (solo si se sospechan comorbilidades)

- **IgE sérica total y específica** (orienta pero no es diagnóstica).
- **Prick test o test de parche** si sospecha de alergia alimentaria o contacto.
- **Cultivo bacteriano o viral** en lesiones infectadas.
- **Biopsia cutánea**: solo en casos atípicos (infiltrado linfocítico con espongiosis).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Objetivos

- Controlar prurito e inflamación.
- Restaurar barrera cutánea.
- Prevenir infecciones y recaídas.

- Educar al paciente y familia.

5.2. Medidas generales y educación

1. **Evitar factores desencadenantes:** calor, lana, jabones, perfumes, estrés.
 2. **Baños cortos (5–10 min)** con agua tibia, sin jabón o con **syndet (pH neutro)**.
 3. Aplicar **emoliente o crema hidratante inmediatamente después del baño** (“regla de los 3 minutos”).
 4. Ropa de **algodón**, mantener uñas cortas.
 5. Evitar rascado directo (uso de guantes o “palmeo”).
 6. Educar sobre **curso crónico y no contagioso**.
-

5.3. Tratamiento farmacológico

Etapas / severidad	Tratamiento principal	Observaciones
Leve	Corticoide tópico de baja o mediana potencia (hidrocortisona 1%, mometasona, betametasona valerato) 1–2 veces/día	Evitar uso prolongado en cara o pliegues
Moderada	Corticoide tópico + emoliente + antihistamínico oral (loratadina o cetirizina)	Control semanal inicial
Grave o refractaria	Corticoide sistémico corto (prednisona 0,5 mg/kg/día × 5–7 días) o inmunomodulador tópico (tacrolimus 0,03–0,1%)	Derivar a dermatología
Infección secundaria	Antibióticos tópicos (mupirocina) o VO (cefalexina 7–10 días)	Cultivar si recidiva frecuente

Refractaria crónica	Dupilumab (anticuerpo anti-IL-4Rα), ciclosporina o metotrexato	Según guía MINSAL 2023, casos severos bajo especialista
----------------------------	--	---

Emolientes: pilar fundamental del tratamiento, incluso sin brote.

5.4. Tratamiento en lactantes

- Evitar corticoides potentes.
- Preferir hidrocortisona 1% o pimecrolimus en pliegues o cara.
- Control frecuente por riesgo de absorción sistémica.

5.5. Fototerapia

- **UVB banda estrecha:** opción en DA moderada a severa refractaria a tratamiento tópico.
- Contraindicada en niños <12 años o antecedentes de cáncer cutáneo.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo / Características	Manejo
Infección bacteriana (<i>S. aureus</i>)	Pústulas, costras mielicéricas (impétigo secundario)	Antibióticos tópicos / VO
Eczema herpético (Kaposi variceliforme)	Coinfección por VHS → vesículas dolorosas diseminadas	Aciclovir VO / IV

Liquenificación crónica	Engrosamiento cutáneo por rascado crónico	Corticoides tópicos, fototerapia
Alteraciones del sueño y ansiedad	Por prurito persistente	Educación y manejo multidisciplinario
Impacto psicosocial	Baja autoestima, ausentismo escolar	Apoyo psicológico y educación familiar

Pronóstico:

- 70–80% mejora o remite antes de la adolescencia.
- Persistencia o recidiva en adultos con formas localizadas (manos, párpados, cuello).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Prurito nocturno intenso + lesiones eccematosas en pliegues → diagnóstico: dermatitis atópica.**
2. La **piel seca (xerosis)** es el primer signo y debe tratarse incluso fuera del brote.
3. Los **emolientes diarios** son la base del manejo; reducen recaídas y necesidad de corticoides.
4. **Corticoides tópicos** son seguros si se usan con la **potencia y duración adecuadas**.
5. En **niños**, las lesiones predominan en cara y superficies extensoras; en **adultos**, en pliegues.
6. **Eczema herpético** es una urgencia dermatológica (vesículas umbilicadas dolorosas).

7. **Educación familiar** es parte integral del tratamiento (curso crónico, no contagioso).



Errores comunes

- Uso excesivo de **corticoides potentes en cara o pliegues** → atrofia cutánea.
 - Suspendir bruscamente corticoides tópicos → rebote inflamatorio.
 - No indicar emolientes entre brotes.
 - Diagnosticar erróneamente “alergia alimentaria” sin respaldo clínico.
 - No tratar infecciones bacterianas secundarias.
 - Confundir DA con escabiosis o dermatitis seborreica en lactantes.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **dermatitis atópica** es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por **prurito intenso, xerosis y lesiones eccematosas** de distribución típica según edad.
2. Es el resultado de una **alteración de la barrera cutánea (filagrina)** y una **respuesta inmunológica Th2**.
3. El diagnóstico es **clínico**, basado en criterios de Hanifin y Rajka.
4. El tratamiento se centra en **emolientes + corticoides tópicos** según severidad.
5. **Evitar desencadenantes ambientales** y mantener medidas de higiene y humectación diaria.
6. Las complicaciones más frecuentes son **infección bacteriana y eczema herpético**.
7. En EUNACOM, la clave diagnóstica es: **niño con prurito, piel seca y lesiones eccematosas en pliegues**.